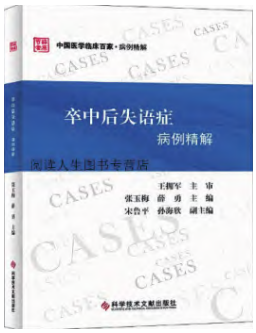
·书　评·　评《卒中后失语症病例精解》

卒中后失语症患者筛查与康复护理的应用进展综述



张玉梅、薛勇编著的《卒中后失语症病例精解》于2019年由科学技术文献出版社出版，该书弥补了我国在卒中后失语症康复方面的薄弱环节。《卒中后失语症病例精解》依据病例研究方法全方位介绍9种失语类型的诊断、治疗。本书共分为9章，分别描述了不同的失语症类型，还介绍了非语言认知障碍、抑郁症状。《卒中后失语症病例精解》一书主要面向神经内科医师、康复医学科医师、全科医师及言语治疗师，详细介绍了诊断和管理卒中后失语症的相关知识以及有效的康复治疗措施，旨在提高医师对卒中后失语症的识别、评估、处理能力，使更多卒中后失语症患者得到及时有效的诊疗，从而有效改善患者言语交际能力。该书具体阐释了各种类型的卒中后失语症病例，其核心模式是每章都聚焦于一种特定的失语症类型展开细化阐述，而且每类失语症病例资料均包含以下部分：病例简介（主诉、现病史、既往病史、入院体检、辅助检查、病因、治疗过程、言语评估经过及诊断结果）与治疗方案（涉及言语功能、非言语表达及相关认知功能、治疗理念、延伸治疗内容等），并附有权威专家点评。除常见的失语症类型外，本书还纳入了一些相对少见的失语症伴随非语言性认知障碍以及失语症伴抑郁症状的复合案例。

通过对《卒中后失语症病例精解》的认真研读可知，目前卒中后失语症的筛查手段已经取得显著的进步和发展，主要包括以下几个方面。首先，是传统量表的广泛使用与完善。美国国立卫生研究院卒中量表评分（National Institutes of Health Stroke Scale，NIHSS）系统包含一个有9个项目的“最佳语言”小节，该小节因其使用简单易行，常在患者入院24 h内用于初步筛查，以快速判断是否存在失语症。其次，国际标准化失语症评估工具的引进与验证。西方失语症评估量表修订版（Western Aphasia Battery-Revised，WAB-R）是一套综合性评估工具，通过评判自发性言语、听力理解、重复、命名、阅读、书写等多方面能力，对患者的语言功能进行全面定量评价，从而为后续个体化语言训练方案的制定提供详实依据。再者，快速筛查工具的本地化开发。为缩短常规评价时间，上海东方医院的俞海萍专家团队将“失语症快速筛查工具（Quick Aphasia Battery，QAB）”汉化为中文版，一项涉及283例脑梗死患者的初步试验表明，中文版QAB具有良好的信度和效度（Cronbach's α 系数达0.962，且与WAB-R相关系数为0.977），可在15 min内完成对患者口语表达、听力理解、阅读等功能的全面测评，在患者筛查过程中大大节省了时间。最后，还有一种新型神经成像技术也开始应用于临床，功能近红外光谱法（functional near-infrared spectroscopy，fNIRs）已经应用于失语症的检测。研究表明，失语症患者在完成命名任务、重复任务、Stroop任务时，其左侧前额叶、布罗卡区等言语相关脑区出现异常激活，患者表现为血液脱氧血红素含量增高或大脑半球一侧化消失，并且伴随患者反应时间延长以及准确率降低。fNIRs技术能够实现对相关脑区进行实时、无干扰的监测，有利于失语症患者大脑功能重组的早期检测以及治疗过程的监测跟踪，能够为实施精准干预提供依据。此外，在掌握各种类型失语症患者特征及严重程度的基础上，分层次筛查策略开始受到临床关注。首先使用简单的评估工具NIHSS中的“最佳语言”小节，对可能的卒中后失语症患者进行初步筛查；如果结果为阳性，则需要使用更加全面的测试工具WAB-R进一步明确其失语症的类型和严重程度；再根据患者不同的失语症类型，选择针对性的专项评估方法，对于是否使用NIHSS-NIART量表作为主要测评方法也有所不同，如对于流畅型失语症患者应选择侧重更复杂的语言任务评估，而非流畅型失语症患者则更倾向于选择非语言认知评估等。这种分层递进的筛查方法，能显著提升诊断的效率和准确性。

根据《卒中后失语症病例精解》中相关内容，总结目前针对该疾病的护理方案主要包括以下方面。（1）个体化康复训练的实施：重点是依据患者的具体情况来制定个体化康复方案，如对患者的口语交流能力、听力理解能力、阅读理解能力以及书写能力等应用波士顿诊断性失语症检查法或WAB-R进行精确的判断，然后在此基础上制定个体化康复方案。如以言语表达障碍为主的患者应重点强化发音、称呼、讲故事等训练；以听力障碍为主要表现的患者应当重点强化其对声音的分辨能力、听指令操作能力。同时，还应当充分考虑患者的年龄、文化、兴趣爱好等个体差异，使不同的患者均能得到满意的疗效。（2）多样化康复技术的应用：除常规的听、说、读、写训练外，还出现了多种先进的康复新技术。如旋律语调疗法主要基于音乐和语言在大脑中的共享区，按照汉语的特点制定相应的音调以及刺激图示卡片，以此来激发患者语言表达的需求和欲望，实际操作中具有良好的治疗效果。另外，强迫性诱导失语治疗的核心任务是在团队交流活动中，强迫患者主动说唱，以此增加患者的交谈次数，提高交流能力。

许利红，曲淑婕*（河北北方学院附属第一医院介入康复科，河北张家口　075000）

*通信作者：曲淑婕，E-mail：qushuj13587@126.com

中国知网　https://www.cnki.net